

# **Guía de práctica clínica para la detección temprana, tratamiento integral, seguimiento y rehabilitación del cáncer de mama**

Versión para pacientes y cuidadores. Guía No. GPC-2013-19.

Ministerio de Salud y Protección Social – Colciencias. Instituto Nacional de Cancerología ESE. Sistema General de Seguridad Social en Salud, Colombia.

Año: 2013 (Bogotá, abril de 2013).

## 2. Resumen

Esta guía explica a pacientes y cuidadores qué es el cáncer de mama, cómo se detecta y diagnostica, cuáles son sus tipos y etapas, qué tratamientos existen (cirugía, quimioterapia, radioterapia y terapia hormonal), qué efectos secundarios pueden aparecer y qué recomendaciones seguir durante el tratamiento. También aborda el impacto emocional y las fuentes de apoyo.

## 3. Índice

- 1 Portada
- 2 Resumen
- 3 Índice
- 4 Abreviaturas
- 5 Glosario
- 6 Epidemiología
- 7 Diagnóstico
- 8 Tratamiento farmacológico
- 9 Tratamiento no farmacológico y manejo
- 10 Seguimiento y pronóstico

## 4. Abreviaturas

- **CDIS:** carcinoma ductal in situ.
- **CLIS:** carcinoma lobular in situ.
- **ER-positivo:** tumor con receptores hormonales positivos para estrógeno y/o progesterona.
- **HER2:** proteína que estimula el crecimiento y la división de las células tumorales.
- **TNM:** sistema de clasificación por tumor (T), ganglios (N) y metástasis (M).
- **RM:** resonancia magnética.
- **BRCA1 / BRCA2:** genes cuya mutación aumenta el riesgo de cáncer de mama.
- **AMESE:** Apoyo a Mujeres con Enfermedades del Seno.

## 5. Glosario

- **Metástasis:** proceso por el cual las células cancerígenas se extienden desde el tumor original a otros tejidos u órganos.
- **Neoadyuvancia:** tratamiento que se administra antes de la cirugía o la radioterapia para reducir el tamaño del tumor y facilitar su remoción.
- **Adyuvancia:** tratamiento que se administra después de la cirugía para eliminar las células cancerígenas que puedan haber quedado.
- **Ganglio centinela:** primer ganglio linfático de la axila por el que drena la mama y, por tanto, el primero que puede verse afectado por el cáncer.
- **Linfedema:** inflamación de la mama y, sobre todo, del brazo por acumulación de líquido, que puede aparecer después de la cirugía de ganglios o años más tarde.

## 6. Epidemiología

El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres, aunque también se presenta, en menor número, en hombres. Se define como la proliferación anormal y desordenada de células mamarias malignas que forma un tumor dentro de la mama, con capacidad de invadir otros órganos. Puede originarse en los lóbulos o en los conductos, y diseminarse por vasos sanguíneos y linfáticos hacia los ganglios de la axila y la clavícula.

La causa del cáncer de mama no se conoce, pero la guía describe factores que aumentan el riesgo de padecerlo: mayor edad; ser portadora de una mutación en BRCA1 o BRCA2; tener madre, hermana o hija con cáncer de mama; primera menstruación antes de los 12 años; menopausia tardía; tener hijos después de los 30 años; no haber tenido hijos ni lactado; terapia de reemplazo hormonal prolongada; obesidad; sedentarismo y consumo abusivo de alcohol.

En los últimos años han mejorado las técnicas de diagnóstico, lo que permite detectar la enfermedad en etapas tempranas. La mamografía como estrategia de diagnóstico precoz ha logrado disminuir hasta en un 25 % el riesgo de morir por cáncer de mama.

## 7. Diagnóstico

Ante cualquier sospecha de cáncer de mama se aconseja consultar primero a un especialista en mama o mastólogo; si no hay uno disponible en el área de atención, se puede consultar al ginecólogo o al médico general.

La detección temprana incluye tres herramientas. La primera es el autoexamen, que cada mujer puede hacer en casa de forma regular, usualmente cada mes, desde la adolescencia y entre cinco y ocho días después del inicio del periodo menstrual, cuando las mamas están menos congestionadas; la palpación debe cubrir toda la glándula hasta la axila. La segunda es el examen clínico de la mama, hecho por personal de salud entrenado mediante inspección y palpación de mamas y axilas, capaz de detectar tumores de poco más de 1 cm; se recomienda al menos cada tres años desde los 20 años y cada año desde los 40. La tercera es la mamografía: en mujeres sin síntomas, la normativa colombiana recomienda hacerla cada dos años después de los 50 años; en mujeres con síntomas, la indica el médico tratante a cualquier edad.

Si hay hallazgos, el médico puede solicitar ecografía, resonancia magnética, biopsia con aguja guiada por ecografía para evaluar los ganglios, y pruebas de receptores de estrógeno y progesterona. Los signos y síntomas de alarma son: masas o bultos en los senos o las axilas; endurecimiento o hinchazón de una parte de la mama; enrojecimiento o descamación del pezón o la mama; hundimiento del pezón; secreción por el pezón fuera de la lactancia; cambios en el tamaño o la forma de las mamas; y dolor en cualquier parte de la mama.

Para clasificar el cáncer de mama se distingue entre formas no invasivas y invasivas. Las no invasivas o in situ incluyen el CLIS, que se desarrolla en los lóbulos sin atravesar sus

paredes, y el CDIS, el más común de los no invasivos, que se desarrolla en los conductos sin salir de ellos. Si no se tratan a tiempo, pueden volverse invasivas. Las invasivas incluyen el carcinoma ductal invasivo, que comienza en los conductos e invade el tejido vecino, y el carcinoma lobular invasivo, que comienza en los lóbulos y se extiende a otros tejidos de la mama. El tumor se clasifica además como ER-positivo si tiene receptores hormonales, y como HER2-positivo si tiene exceso de esta proteína, lo que se asocia a crecimiento rápido.

La etapa se define con el sistema TNM. En la etapa 0 el CDIS sigue en los conductos o lóbulos. En la etapa I el tumor mide 2 cm o menos y no afecta los ganglios. En la etapa II (A y B) el tumor puede medir menos de 2 cm, entre 2 y 5 cm o más de 5 cm, y puede haber ganglios axilares comprometidos. En la etapa III (A, B y C) hay mayor compromiso ganglionar, incluidos ganglios cercanos al esternón o a la clavícula, y puede extenderse a la pared del pecho como cáncer inflamatorio, sin llegar a otros órganos. En la etapa IV el cáncer ha invadido otros órganos, como huesos, pulmones, hígado o cerebro.

## 8. Tratamiento farmacológico

Después del diagnóstico, en etapa temprana o avanzada, no deben pasar más de tres meses para iniciar el tratamiento. Según la etapa, el objetivo es eliminar el tumor, reducirlo o, en casos muy avanzados, aliviar el dolor.

La quimioterapia usa medicamentos que atacan las células cancerígenas y evitan que se dividan. Se administra por vía intravenosa o en tabletas, con uno o varios medicamentos combinados. Antes de la cirugía o la radioterapia se llama neoadyuvancia; después de la cirugía, adyuvancia. Sus efectos secundarios incluyen pérdida de apetito, cansancio, caída del cabello, úlceras en la boca, cambios o interrupción de la menstruación, problemas de fertilidad, náuseas y vómito, sangrado o hematomas con golpes leves, disminución de glóbulos blancos con infecciones o fiebre, y problemas cardíacos.

Cuando el tumor es ER-positivo se puede indicar terapia hormonal después de la cirugía y de la quimioterapia, para bloquear el efecto del estrógeno o reducir sus niveles y así evitar que la enfermedad reaparezca. Estas terapias no deben suspenderse, porque son más efectivas cuando se toman por largo tiempo. Sus efectos secundarios generales son sofocos, debilidad de los huesos, dolor articular y un ligero aumento del riesgo de coágulos y de cáncer de útero.

**Tabla 1. Tratamientos sistémicos: dosis, frecuencia, duración y observaciones**

| Fármaco                                   | Dosis                      | Frecuencia      | Duración                                                   | Observaciones                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quimioterapia (uno o varios medicamentos) | No especificada en la guía | No especificada | Antes de la cirugía (neoadyuvancia) o después (adyuvancia) | Vía intravenosa o en tabletas. Vigilar fiebre e infecciones por baja de glóbulos blancos, sangrados y problemas cardíacos                                |
| Tamoxifeno (antiestrógeno)                | No especificada en la guía | No especificada | Largo plazo; no suspender                                  | Para pacientes premenopáusicas y con enfermedad metastásica. Efectos: calores, flujo vaginal, cambios de humor; rara vez cáncer de endometrio y coágulos |
| Inhibidores de la aromatasa               | No especificada en la guía | No especificada | Largo plazo; no suspender                                  | Recomendados en mujeres posmenopáusicas. Efectos: calores, dolor articular, osteoporosis y fracturas                                                     |
| Ablación ovárica (procedimiento)          | No aplica                  | Única           | Permanente                                                 | Remoción de los ovarios, principales productores de estrógenos. Para mujeres premenopáusicas con tumor positivo para estrógenos                          |

## 9. Tratamiento no farmacológico y manejo

La cirugía suele ser la primera opción de tratamiento porque permite extraer el tumor y evaluar los ganglios. En la cirugía conservadora (tumorectomía o resección local amplia) se retira solo el tumor con un margen de tejido sano, a veces con los ganglios axilares; se usa en etapas tempranas, preserva la apariencia de la mama y puede requerir radioterapia después. No es apta si hubo radioterapia previa en la mama, hay lesiones sospechosas extendidas en toda la mama, hay varios tumores que no se pueden retirar en una sola operación, tumorectomías previas no removieron el cáncer, hay esclerodermia o lupus, hay embarazo con posible necesidad de radioterapia, o el tumor mide más de 5 cm y no se reduce con tratamiento previo. La mastectomía retira toda la mama con piel, grasa y pezón, y se indica si no hay suficiente tejido sano. La paciente decide entre ambas junto con el mastólogo.

Para los ganglios se hace biopsia del ganglio centinela y, si tiene cáncer, disección de ganglios axilares. La reconstrucción puede hacerse durante la mastectomía o después, con implantes o tejido propio. La cirugía de ganglios puede causar adormecimiento del brazo, limitación del hombro y linfedema.

La radioterapia usa rayos de alta energía de forma externa o por braquiterapia. Se aplica sobre la mama tras cirugía conservadora por cáncer invasivo temprano o CDIS con riesgo de recaída; sobre la pared torácica tras mastectomía si hay riesgo de recaída local; y sobre los ganglios si no hubo cirugía o persisten ganglios comprometidos. Puede causar hinchazón y endurecimiento de la mama, piel como quemada por el sol, cansancio, náuseas y diarrea.

Durante el tratamiento se recomienda alimentación balanceada con frutas, verduras y cereales, líquidos abundantes, poco café y grasas, sin alcohol ni cigarrillo, y tres comidas

al día. Ejercicio moderado, caminatas diarias y descanso suficiente reducen el cansancio y la ansiedad. Se recomienda asesoría psicológica o grupos de apoyo, y se debe consultar si hay nerviosismo intenso, alteraciones del sueño, desánimo, dificultad para las actividades diarias o ideas de suicidio.

## 10. Seguimiento y pronóstico

La guía para pacientes no fija una periodicidad de controles después del tratamiento; indica que la paciente acuerde con su médico tratante el procedimiento y las condiciones de seguimiento adecuados para su caso. Durante y después del tratamiento se deben vigilar los efectos secundarios: la mayoría son transitorios, pero el linfedema puede aparecer años después de la cirugía de ganglios. Son signos de alarma la fiebre o las infecciones durante la quimioterapia, los sangrados sin causa y la aparición de nuevos bultos o cambios en la mama.

El pronóstico depende de la etapa: en etapas tempranas es más probable un tratamiento adecuado, mientras que sin atención la enfermedad puede extenderse. Los tumores HER2-positivos crecen más rápido, y los carcinomas in situ no tratados pueden volverse invasivos. El apoyo emocional de familia, otras pacientes y grupos especializados forma parte de la rehabilitación.